

1절. 빈혈

- 순환혈액의 적혈구 수와 헤모글로빈이 정상보다 낮을 때
(남성 13g/dl, 여성 12g/dl, 임산부 11g/dl 미만) 수치가 낮더라도 증상이 보이면 치료!
- 한의학의 '혈허'에 속함
- 원인: 선천품부부족(先天稟賦不足), 비위허약(脾胃虛弱), 생화핍원(生化乏元), 실혈과다(失血過多), 구병불유(久病不愈), 사려과다(思慮過多)로 인한 음혈손상(陰血損傷), 어혈조락(瘀血阻絡)으로 인한 신혈불생(新血不生)
- 증상: 피부창백(皮膚蒼白), 면색무화(面色無華), 피곤핍력(疲倦乏力 기운 없음), 두훈이명(頭暈耳鳴), 기억력감퇴, 기급(氣急, 숨 가쁨), 심계*(心悸), 식욕부진, 오심, 구토, 기창(氣脹), 흉민(胸悶), 설사, 월경실조, 성욕감퇴. 검사상 적혈구 수와 헤모글로빈이 정상보다 낮음
✓ 기허 증상이 많음 ⇒ 혈만 보충하지 말고 보기+보혈 같이.
- * 심계: 빈혈 → 피가 부족함 → 심장이 박출량 높이려고 더 빨리 뛴 심계를 잘 감별해야함. 심장질환 자체/빈혈/갑상선 문제 /자율신경계 문제/감염(감기 등) 등 원인 다양
- 치료원칙: 건보비위(健補脾胃) 익기생혈(益氣生血)
→ 양명경 위주로 온보지법(溫補之法) 사용

· 분류: 3가지

① 적혈구 생산 감소 (조혈불량) 생산 자체가 잘 안 됨

- 1) 혈구 생산장소인 줄기세포와 그것을 둘러싼 골수의 지지조직의 이상
ex) 재생불량성 빈혈: 모든 혈구가 감소
순적혈구무형성증: 적혈구만 감소
- 2) 혈색소의 원료인 철의 결핍 ex) 철결핍성 빈혈.
섭취량 자체가 부족하거나, 소화기문제로 흡수가 (안되는 경우도 있음
- 3) 적혈모구를 성숙시키는 비타민 B12와 엽산의 부족 ex) 거대적혈모구 빈혈
- 4) 혈색소의 합성효소와 비타민 B6 등의 보조효소의 이상 ex) 철적모구빈혈

✓ 치료할 땐 골수 이상 / 철 부족 / 비타민 등 보조효소 이상 정도로만 구분

② 적혈구의 파괴 증가 (용혈성 빈혈) 혈구모양의 이상, 성숙의 이상 등이 원인

- 1) 혈관외용혈: 자가면역용혈빈혈, 유전구형적혈구증, PK결핍증, 지중해빈혈증
보통 비장 기능항진 시 많이 나타남
- 2) 혈관내용혈: 적혈구파괴증후군(DIC, 인공판막 등), 발작한랭혈색소뇨증(PCH), 발작야간혈색소증(PNH), 행군혈색소뇨증, 열상(화상)

③ 급만성 실혈 (출혈)

출혈 자체로 인한 출혈 후 빈혈, 만성적 소량출혈로 인한 철결핍성 빈혈

ex) 자궁근종으로 인한 생리과다 / 지혈이상으로 인한 잦은 출혈 / 수술 시

2절. 백혈구 감소증

· 혈액 중 백혈구 수가 mm³당 4,000개 이하로 지속적으로 감소하는 것. 주로 중성구의 감소로 말미암음 cf. 정상: 4,000~9,000 사이

· 백혈구의 증감

- 1) 세균 감염: 호중구 증가, 림프구 감소
[예외] 장티푸스/파라티푸스, 좁쌀결핵/패혈증: 호중구 감소
백일해: 림프구 증가
- 2) 바이러스 감염: 호중구 감소, 림프구 증가
[예외] HIV 감염/홍역/폴리오 등: 림프구 감소
- 3) 부신피질스테로이드제: 호중구 증가, 호산구 감소, 림프구 감소
- 4) 전신성 홍반성 루푸스: 호중구 감소, 림프구 감소
- 5) 항암제, 방사선: 호중구 감소, 림프구 감소
- 6) 혈액질환
급성백혈병: 호중구 감소
만성골수성백혈병/만성림프구성백혈병: 백혈구 증가

· 조혈줄기세포장애에 의한 골수에서의 생산저하에 의해 많이 생김

- 1) 범혈구감소증 일으키는 질환
ex) 재생불량빈혈, 급성백혈병, 골수형성이상증후군, 발작야간 혈색소뇨증, 거대적혈모구빈혈
- 2) 방사선 조사, 항암제 투여

· 유발인자

직접 조혈세포를 해하는 벤젠, 항종양약물, X-ray와 방사성 물질, 백혈구를 감소시키는 약물과민, 골수조혈을 억제하고 백혈구를 파괴하는 세균, 바이러스 등의 병원체나 독소, 전신홍반성 낭창, 비기능항진, 재생불량성 빈혈, 악성종양의 전이, 영양결핍, 면역 글로불린 반응 등

· 분류

- ① 속발성 백혈구 감소증: 속발성 병인 존재함. 감기, 기관지염, 폐렴, 중이염, 비뇨생식기 감염을 앓고 감염병소가 있으면 잘 낫지 않음
✓ 코로나 : 요즘 코로나는 발열이 심하지 않고 코감기와 유사
계속계속 변이가 일어나는 중..
- ② 원인불명성 백혈구 감소증: 속발성 병인 없음*. 피로, 전신피력, 저열, 도한, 실명 등
→ 음허 증상
* 사실 못 찾은거지, 그냥 감소하는 경우는 없음

· 대개 허증에 속함. 주로 '기허'*

- 1) 병기: 비위허약(脾胃虛弱)으로 기혈생화무원(氣血生化無源)
- 2) 증상: 두훈목현(頭暈目眩), 소기나연(少氣懶言), 권태핍력(倦怠乏力), 자한(自汗) 등의 원기부족(元氣不足) 증상

* 피피티엔 기허라고 되어있는데 사실 [혈허가 기허]와 비슷하고 [백혈구 증상이 음허]와 좀 더 비슷하다고 하시네요,,

3절. 출혈

1) 변증치료

(1) 해혈(咳血) 기침 하면서 피가 나옴

- 원인: 폐장에 화열이 심한 데서 기인
- 증상: 해수가 심하며 이때 출혈함
- 분류

① 간화범폐(肝火犯肺)

- 1) 증상: 해수(咳嗽) 담중대혈(痰中帶血)* 대구객혈(大口咯血)*
 혈색선홍(血色鮮紅) 자암(紫暗) 흉협통(胸脇痛) 번조이노(煩燥易怒)
 구고(口苦) 맥현(脈弦) 등 - 간화 증상 동반
 * 담중대혈: 가래 속에 피가 섞여있음
 * 대구객혈: 크게 기침할 때 객혈

- 2) 치법: 청간청폐지혈(淸肝淸肺止血)
 → 수족궐음·수태음경 위주 / 사법(∴실증이므로)

3) 치료혈

주혈: 행간(行間) → 간의 형화혈(榮火穴, =형혈. 청열해줌)
 어제(魚際) → 폐의 형화혈
 배혈: 노궁(勞宮) → 심포경의 형화혈
 폐수(肺俞) → 폐의 수혈

② 음허화왕(陰虛火旺)

- 1) 증상: 해수소담(咳嗽少痰) 담중대혈(痰中帶血) 혈색선홍(血色鮮紅)
 조열도한(潮熱盜汗) 신체이수(身體羸瘦) 설홍소태(舌紅少苔) 맥세삭
- 2) 치법: 익음청폐지혈(益陰淸肺止血)
 → 수태음·족소음경 위주 / 보사를 겸함(∴허증/실증이 겸하기 때문)
- 3) 치료혈
 주혈: 척택(尺澤) → 폐의 합수혈 / 보
 공최(孔最) → 폐의 극혈 어제(魚際) → 폐의 형화혈 / 사
 배혈: 백노(百勞) 연곡(然谷) 태계(太谿)

(2) 육혈(衄血)

- 원인: 내상칠정이 중요한 원인
 양명경과 폐경의 울열 / 상한병에 마땅히 발한시켜야 할 때 발한을 못 시키면 화열이 혈을 건박(牽迫)한 데서 기인. 주로 폐열, 위열, 간화로 유발됨
- 증상: 육혈은 비공(鼻孔)으로 출혈되는 것이지만, 대량으로 출혈이 군박(窘迫)하면 구강으로 동시에 출혈됨

· 분류

① 폐열(肺熱)

- 1) 증상: 비조인건(鼻燥咽乾)* 신열해수(身熱咳嗽) 설홍맥삭(舌紅脈數)
 * 비조인건: 코/목구멍 마르는 건조증상
- 2) 치법: 청사폐열(淸瀉肺熱) 량혈지혈(涼血止血)
 → 독맥·수태음경 위주 / 사법

3) 치료혈

주혈: 상성(上星)* 합곡(合谷) 소상(少商, 정혈)
 배혈: 풍부(風府) 천부(天府)
 * 상성: 코피났을 때 눌러주는 부분

② 간화(肝火)

- 1) 증상: 비늑(鼻衄) 혈색선홍(血色鮮紅) 두통현훈(頭痛眩暈) 목적(目赤) 구고(口苦)
 번조이노(煩燥易怒) 설홍(舌紅) 태황(苔黃) 맥현삭(脈弦數)
 ✓ 뇌압이 높을 땐, 오히려 코피가 터져주는 게 좋음
- 2) 치법: 청간화지혈(淸肝火止血)
 → 독맥·족궐음·족소음경 위주로 사법
 ✓ 간 병변 있을 때 코피의 형태로 출혈이 나타날 수 있음
- 3) 치료혈
 주혈: 태단(兌端) 행간(行間) (간의 형화혈 / 사)
 배혈: 곡천(曲泉) 용천(湧泉) 위중(委中)*
 * 위중: 설열지혈 ⇒ 혈열 있을 때 응용

✓ 코피 많이 나는 애들한테 일단은 보법을 사용. 결국엔 혈관이 약해서, 혈관을 강화시켜주는 치료도 병행

✓ 간 안 좋아도 출혈이 잘 생김 → 성인일 경우 고려해야하는 요소

✓ 혈소판(골수) 문제, 뇌압이 올라도 코피

(3) 토혈(吐血), 구혈(嘔血)

└ 구: '웁' 소리와 함께 구역질하면서 나오는 것

└ 토: '웁' 소리 없이 나오는 것 ex. 역류성 식도염 = 토혈, 토산

→ 기전은 약간 다르지만 쓰는 처방/혈자리는 거의 비슷함

· 원인

└ 토혈: 노력과도, 식상(食傷), 음주과도

└ 구혈: 폭노(暴怒), 방로(房勞), 허로, 음주과도, 양허, 노상(勞傷)

✓ 주로 위중적열, 간화범위, 비기허약 등에 의해 생김

· 증상: 토혈/구혈 모두 구강으로 출혈하는 것

└ 토혈: 구역성(嘔逆聲) 없이 대량 출혈

└ 구혈: 구역성을 발하면서 출혈

· 분류

① 위중적열(胃中積熱) 실열이 있는 것

1) 증상: 토혈선홍(吐血鮮紅) 자암(紫暗) 완복창통(脘腹脹痛) 구취(口臭)

변비(便秘) 대변색흑(大便色黑) 설홍태황니(舌紅苔黃膩) 맥활삭(脈滑數)

2) 치법: 청위강역지혈(淸胃降逆止血) → 독맥과 족양명경 위주 / 사법

3) 치료혈

주혈: 상완(上腕) 내정(內庭, 위경의 형수혈(榮水穴) ⇒ 청열)

배혈: 극문(郄門, 심포경의 극혈)

② 간화범위(肝火犯胃)

1) 증상: 토혈선홍(吐血鮮紅) 자암(紫暗) 구고협통(口苦脇痛) 번조이노(煩燥易怒)

설홍강(舌紅絳) 맥현삭(脈弦數) - 간화가 주 증상

2) 치법: 청간화위(淸肝和胃) 사화지혈(瀉火止血) → 족양명-족궐음경 위주로 사법

3) 치료혈

주혈: 양구(梁丘, 위의 극혈) 태충(太衝, 간의 원혈)

배혈: 노궁(勞宮, 심포경의 형화혈 ⇒ 열을 사해줌)

③ 비기허약(脾氣虛弱)

1) 증상: 토혈교다(吐血較多) 색자암(色紫暗) 면색황백(面色黃白) 신피식소(神疲食少)

설담태백(舌淡苔白) 맥침세(脈沈細)

- 비기가 약해서 섭혈 못해서 나타나는 증상

2) 치법: 건비섭혈(健脾攝血)

→ 족태음-족양명-임맥 위주로 보법/구법

3) 치료혈

주혈: 중완(中腕, 위의 모혈) 족삼리(足三里, 위의 합혈)

배혈: 비수(脾俞) 은백(隱白, 비의 정혈)

(4) 객혈(咯血)

· 원인: 신수(腎水)가 부족하며, 정혈(精血)이 고갈된 데 기인

· 증상: 혈설(血屑)을 객출하며, 혹은 객출하여도 불출(不出)하며,

혹은 홍사(紅絲)와 같은 혈선(血線)이 섞이기도 함

(5) 수혈(嗽血) 담이 많이 섞인 기침

· 원인: 비장에 습담 혹은 담화(痰火)에 기인

· 증상: 해수담성하며 담중에 혈이 섞임

(6) 타혈(唾血)

· 원인:腎에 속하며, 음허화동에 기인

· 증상: 선혈(鮮血)이 타액을 따라 배출됨

7) 변혈(便血) 변중에 혈이 비치는 것

- ✓ 상부/하부 위장관 출혈 → 출혈 위치에 따라 증상 달라짐
- **상부** 위장관(위/소장) 출혈 [원혈]: 대변에 피가 섞임, 오래되면 짜장면처럼 어두운 홍색
- **하부** 위장관(대장/항문) 출혈 [근혈]: 뒤쪽에 출혈이 있는 것. 밑으로 내려올수록 혈이 선홍색임 ex) 치질, 대장 종양, 염증성 장 질환
- 원인: 음기가 내결되어 영혈이 순행하지 못하고, 장간(腸間)으로 삼입(滲入)하여 항문, 즉 대변으로 출혈하는 것 / 습독·열독·식독 등이 주요 원인
- 증상: 혈종대변이하(血從大便而下) 대변을 따라 혈이 나옴
- 선변후혈 / 선혈후변
 - └ 선변후혈 - 허: 비위허약하여 비불섭혈하기 때문 → **상부 출혈**
 - └ 선혈후변 - 실: 대장습열로 혈락(血絡)을 작상(灼傷)하기 때문 → **하부 출혈**
- 분류
 - ① 비기허약(脾氣虛弱) 상부 위장관 출혈 (원혈)
 - 1) 증상: 선변후혈(先便後血) 혈색암(血色暗) 복통은은(腹痛隱隱) 면색불화(面色不華) 신피나언(神疲懶言) 식소(食少) 설담(舌淡) 맥약(脈弱)
 - 2) 치법: 건비섭혈(健脾攝血)
 - 임맥, 족태음, 족양명경 위주로 보법/구법
 - 3) 치료혈
 - 주혈: 관원(關元) 태백(太白, 비의 원혈)
 - 배혈: 족삼리(足三里) 회양(會陽)
 - ② 대장습열(大腸濕熱) 하부 위장관 출혈 (근혈)
 - 1) 증상: 선혈후변(先血後便) 혈색선홍(血色鮮紅) 항문작열(肛門灼熱) 동통(疼痛) 태황니(苔黃膩) 맥삭(脈數)
 - 2) 치법: 청대장습열(淸大腸濕熱)
 - 족태양·족양명·족태음 위주로 사법
 - 3) 치료혈
 - 주혈: 대장수(大腸俞) 장강(長強) 차료(次膠) → 항문 주위 혈들
 - 배혈: 비수(脾俞) 상거허(上巨虛) 승산(承山)
- ✓ 치질: 대장경도 많이 쓰지만, 방광경도 많이 씀

(8) 뇨혈(尿血)

- 원인: 음허화왕, 심화항성이 주요 병인. 그 병기는 열상혈락(熱傷血絡)하여 혈이 소변을 따라 나오는 것
- 증상: 소변에 혈이 비치는 것
- 분류
 - ① 음허화왕(陰虛火旺)
 - 1) 증상: 혈뇨(血尿) 소변단적(小便短赤) 조열도한(潮熱盜汗) 요퇴산연(腰腿痠軟) 설홍소태(舌紅少苔) 맥세삭(脈細數)
 - 2) 치법: 양음청열지혈(養陰淸熱止血)
 - 독맥·임맥·족궐음·족소음경 위주 / 보사 겸용
 - 3) 치료혈
 - 주혈: 명문(命門) 신수(腎俞) 관원(關元) → 보법
 - 배혈: 음곡(陰谷) 태계(太谿) 대둔(大敦, 간의 정혈) → 사법
 - ② 심화항성(心火亢盛)
 - 1) 증상: 혈뇨(血尿) 색선홍(色鮮紅) 소변열적(小便熱積) 심번구갈(心煩口渴) 구설생창(口舌生瘡) 설첨홍(舌尖紅) 맥삭(脈數)
 - 염증질환에서 많이 보이는 증상
 - 2) 치법: 청영혈(淸營血) 사심화(瀉心火)
 - 임맥·족궐음·족소음경 위주 / 보사 겸용
 - 3) 치료혈
 - 주혈: 관원(關元) 노궁(勞宮)
 - 배혈: 연곡(然谷, 심의 형화혈)

(9) 혈소판감소성 자반병

· 분류

① 혈열망행(血熱妄行) C 실증

- 1) 증상: 피부에 청자색(靑紫色) 반점(斑點)/반괴(斑塊) 출현. 비뚤(鼻衄) 치뚤(齒衄) 변혈(便血) 뇨혈(尿血)을 동반하거나, 발열(發熱) 구갈(口渴) 변비(便秘) 설홍(舌紅) 태황(苔黃) 맥현삭(脈弦數)이 있음
- 2) 치법: 청열량혈(淸熱涼血)
→ 양명경 위주로 사법
- 3) 치료혈: 곡지(曲池) 합곡(合谷) 대추(大椎) 중완(中腕) 족삼리(足三里) 혈해(血海)
→ 사법

② 음허화왕(陰虛火旺)

- 1) 증상: 피부에 청자색(靑紫色) 반점(斑點)/반괴(斑塊)가 나타나기도 없어지기도 함.
보통 비뚤(鼻衄) 치뚤(齒衄) 월경과다(月經過多) 관홍(觀紅) 심번(心煩) 구갈(口渴) 수족심열(手足心熱)을 동반하거나, 조열(潮熱) 도한(盜汗) 설질홍(舌質紅) 태소(苔少) 맥세삭(脈細數)이 있음
- 2) 치법: 자음강화(滋陰降火)
→ 족소음신경 위주로 보법
- 3) 치료혈: 태계(太谿) 조해(照海) 삼음교(三陰交) 혈해(血海) + 족소음신경도 같이

③ 기불섭혈(氣不攝血)

- 1) 증상: 구병불유(久病不愈, 오래되어 낫지 않고)하며 기뚤(肌衄)이 반복 발생하여 신피핍력(神疲乏力) 두훈목현(頭暈目眩) 면색창백(面色蒼白) 혹은 위황(萎黃) 식욕부진(食慾不振) 설질담(舌質淡) 맥세약(脈細弱)이 있음
- 2) 치법: 건비익기(健脾益氣)
→ 족양명위경 위주 취혈, 온구(溫灸) 사용
- 3) 치료혈: 족삼리(足三里) 음릉천(陰陵泉) 격수(膈俞) 비수(脾俞) 삼음교(三陰交)

(10) 백혈구감소증

- 치료혈: 족삼리(足三里) 삼음교(三陰交) 대추(大椎) 혈해(血海) 비수(脾俞) 신수(腎俞) 격수(膈俞) → 보법/구법

3절. 화열병

1. 개요

: 火란?

- 火와 熱 감기 걸렸을 때: '열'이 오른다
짜증날 때: '화'가 오른다

- 熱

: 풍열, 서열, 습열 등 대개 외음에 속함

- 火

: 심화상염, 간화항성, 위화치성 등 항상 내생한 화열내요(火熱內擾)의 병리반응상태가 됨. 少火는 정기에 속함

· 특징

① 火는 내음(內陰) 외양(外陽), 주로 동(動)을 주관

② 군화(君火)(人火), 상화(相火)(天火)로 나눔

└ 군화: 형(形)과 질(質)이 상생하여 오행에 배열됨, 眞心 小腸氣에 속함

└ 상화: 근거 없이 발생하여 자기 직분을 지키며, 명령을 품수(稟受)하며, 또는 그 동작으로 인해 나타나기도 함, 心包絡 三焦氣에 속함

천기는 생물을 주관하므로 항상 動, 인간도 생체이므로 항상 動

→ 항상 動하는 것은 상화의 작용 (⇒ 문제를 일으키는 것도 주로 상화)

③ 소화(少火)와 장화(壯火)

└ 소화: 인체의 정기로서 장부 내에 밀장(謐藏)되어 온후, 생화작용

└ 장화: 양성태과하여 항렬한 火를 이루어 인체 정기를 모산(耗散)할 때는 병사(病邪)

④ 火는 원기(元氣), 곡기(穀氣), 진기(眞氣)의 적

· 화열의 성질

- ① 火熱爲陽邪 화열위양사 其性火燄灼炎上 기성화번작염상(화열은 양사에 속함. 그 성질은 번,작, 위로 올라가는 것)
- ② 耗傷陰津모상음진 易生燥熱이생조열 (음진을 손상하여 조열이 발생하기 쉽게 만들) → 元氣之敵원기지지적(원기의 적)
- ③ 生風動血생풍동혈 易致腫瘍이치종양(종양, 창양 등이 화에 속함)
- ④ 與心相應여심상응(심장과 같이 응함)

· 장부 궤양지화(臟腑 厥陽之火)

: 오지(五志)의 내부에 근거하여 육욕(六欲)과 칠정(七情)이 격동하면 火가 따라서 발동하는 것

- 대노(大怒): 간(크게 노하면 간화)

취포(醉飽): 위(너무 많이 먹거나 취하면 위화)

방로(房勞): 신

비애(悲哀): 폐

✓ 심은 군주지관으로 자분(自焚)하면 죽음(병사는 심포에서 받음)

· 실열

: 脈洪盛有力맥홍성유력, 能食而熱능식이열(잘 먹으면서 열 생김)

內外皆熱내외개열(안/밖 모두 열남), 口舌乾燥구설건조

日夜潮熱일야조열(낮/밤 상관없이 조열)

大小便閉대소변폐 或難혹난(대소변 폐하거나 난하게 됨)

· 허열

: 脈虛弱無力맥허약무력, 不能食而熱불능식이열, 自汗자한, 短氣단기

潮熱有間조열유간(조열에 간격이 있음)

口燥不渴구조불갈(입은 마르데 물을 마시고 싶진 않음)

2. 한의학적 고찰: 치료

1) 치료원칙 및 기본치료혈

(1) 화열(火熱)의 치료원칙

- ① 화열사의 침자법은 일반적으로 천자(淺刺)하며, 유침하지 않고, 자락을 주로 사용
- ② 기경팔맥 중 독맥의 혈을 선택하여 주로 자락하거나 사법을 사용

✓ 독맥은

① 땀이 수문을 열어 수량을 조절하듯이 경기(經氣)의 성쇠를 조절하며

제양(諸陽)을 통독하는데 양기의 태과부족을 조절한다는 관점

② 정사상쟁 시의 격렬한 반응이 발열로 이어질 때 거사함으로써 해열할 수 있다는 관점

→ 발열 질환에 자락을 위주로 치료하는 근거가 됨 ex. 외감발열 시 大椎대추를 자락

- ③ 각 경락의 오수혈 중 음양경의 교접처인 정혈과, 신열(身熱)을 주(主)하는 형혈을 많이 활용

✓ 양경의 경우 반복 발생하여 화혈(火穴)인 경혈도 사용 가능

✓ 혈열을 치료할 때는 혈해, 위중 선택 가능

- ④ 자음(滋陰)의 의미도 간과해서는 안 됨

(2) 기본치료혈

- ① 골증열(骨蒸熱): 崔氏四華穴최씨사화혈* 膏肓고황三里삼리(족삼리) 魄戶백호 大椎대추 肺俞폐수 腎俞신수

✓ 골증열에 치건조(齒乾燥)한 경우 대추에 땀을 땀

* 최씨사화혈(崔氏四華穴)

- 취혈 ㄴ폐수, 고황

→ 1. 엄지발가락 끝과 위중혈 사이의 거리를 실로 재어 반절(로 접음)

→ 2. 그 중심을 결후(結喉, 갑상연골)에 대고, 그 끝을 양 견갑부로 넘겨

하수(下垂)하여(내려뜨려) 척추와 만나는 점을 잡음

→ 3. 양 구각(口角, 입의 양쪽 구석) 사이의 거리를 한 변으로 하는 정사각형의

중심부를 척추와 만나는 점에 대어 그 네 꼭지점을 취혈

- 주치: 폐결핵, 허약리쇠(虛弱羸衰), 폐기종, 기관지염, 천식, 효천, 토혈, 골증조열, 해수담천 등

- ② 골증노열(骨蒸勞熱): 膏肓고황* 足三里족삼리

* 고황: 음허할 때 많이 사용

- ③ 오심열(손발바닥&심장의 5심이 모두 열): 湧泉용천 勞宮노궁 百會백회 心俞심수 合谷합곡 內關내관 十宣십선혈

- ④ 음허화동(陰虛火動): 腎俞(신수) 命門(명문) 關元(관원) 氣海(기해)
- ⑤ 허번구건(虛煩口乾): 肺俞(폐수)

2) 변증

: 화열병의 종류

(1) 오장열(五臟熱)

(2) 장부열(臟腑熱)의 발생부위

· 먼저 붉어지는 부위: 심열병 - 안(顔, 얼굴)(액(額, 이마))

비열병 - 비(鼻)

간열병 - 좌협(左頰, 왼쪽 뺨)

폐열병 - 우협(右頰)

신열병 - 턱

· 심, 폐: 흉부-배부(背部) 사이 ⇒ 심이 열하면 흉이 열하고, 폐가 열하면 배부가 열함

· 간담: 협부(脇部) / 위: 제상(臍上) / 신: 요부(腰部) / 장(腸): 제하(臍下)에 있음

⇒ 간담/위/신/장이 열하면 각각 협부/제상/요부/제하가 열함

(3) 삼초열(三焦熱)

· ① 상초열: 眼目赤痛(안목적통) 頭項腫痛(두항종통) 口舌生瘡(구설생창)

· ② 중초열: 胸膈煩燥(흉격번조) 飲食不味(음식불미)

· ③ 하초열: 小便赤澀(소변적삽) 大便秘結(대변비결) 尿血(뇨혈) 淋瀝(임폐)

(4) 적열(積熱)

· 원인: 삼초구열(三焦俱熱)로 장부에 열적(熱積)됨

✓ 삼초 모두 열날 때 장부에 열적하므로 3가지를 모두 포함

· 증상: 頰赤煩渴(협적번갈) 口舌生瘡(구설생창) 便秘澀(변비삽) 癰疽瘡癤(옹주창열) 遺精(유정)

(5) 골증열(骨蒸熱): 열이 골에서부터 나온다 하여 '골증'이라 함

· 원인: 陰氣不足(음기부족) 血氣不營(혈기불영)

· 증상: 咳嗽發熱(해수발열), 咯血吐血(객혈토담), 白濁(백탁) 淫白(음백) 배설, 遺精(유정)

盜汗(도한), 精神(정신)이 恍惚(황홀), 점차 消瘦(소수)하여 勞極(노극)증이 됨

✓ 결핵 증상과 유사: 우리가 생각하는 '음허' 증상이 결핵 환자에 많이 나타남

ex. 폐경기도 아닌데 열이 잘 오름 / 장 결핵 → 설사 / 신장 결핵 → 음허화열

(6) 오심열(五心熱)

· 원인: 심화(心火)가 비토(脾土)에 하함(下陷)하여 서함(舒陷)하지 못하고 울결됨

근본은 혈허에서 기인 / 혹은 냉물(冷物)을 과식하여 양기가 비토중에 억울(抑鬱)

되어 발함 / 소아 상식(傷食)의 경우에도 발함

· 증상: 수족장심(手足掌心)과 심장부가 다 열한 것

(7) 조열(潮熱): 열이 조수와 같이 일정한 시간에 발함

· 평조(平潮, 오전 3~5시)의 조열: 열이 양분에 있음 ⇒ 肺氣(폐기)가 주관

· 일포(日晡, 오후 3~5시)의 조열: 열이 음분에 있음 ⇒ 腎氣(신기)가 주관

└ 오전에 발생하는 조열 = 기허조열

└ 오후에 발생하는 조열 = 혈허조열

└ 오전·오후에 다발생하는 조열 = 양허(兩虛)조열

+ 기운 없는 것: 언제 기운 없는지에 따라 → 오전/오후

- └ 오전에 기운 없는 것: (기허일 수도 있지만) 심장이 약할 때

- └ 오후에 기운 없는 것: 간이 안 좋을 때

- └ 뭐 조금만 해도 피곤한 것: 갑상선 약할 때 ← 갑상선 = 배터리

- └ 그냥 체력이 약한 것: 심장이 약할 때 ← 심장 = 엔진

→ 선천적으로 허약한 사람은 병을 병으로 인식 못하기도 함

(8) 허번(虛煩)

· 원인: 陰虛內熱(음허내열)

허로환자의 腎虛心旺(신허심왕) 傷寒吐下(상한토하) 霍亂吐瀉(곽란토사) 후 진액 고갈

· 증상: 심흥이 煩擾(번요)하여 평안하지 못한 것

(9) 음허화동(陰虛火動)

· 증상: 오후부터 야간까지 發熱(발열), 面赤(면적) 唇紅(립홍) 面赤(면적) 唇紅(립홍) 盜汗(도한),

咳嗽痰盛(해수담성), 咯血(객혈) 唾血(타혈), 氣力困憊(기력곤타), 形體消瘦(형체소수)

(10) 음허(陰虛)·양허(陽虛)

- 원인: 양허 - 기포상위(飢飽傷胃) / 음허 - 방로상신(房勞傷腎)
- 증상
 - └ 양허: 발열이 주간(晝間)에 심하고, 야간에 경(輕)하며, 구중무미(口中無味)함
 - └ 음허: 오후에 발열하여 야반(夜半)에는 그치며, 구중유미(口中有味)함

3) 기타치료

(1) 이침: 耳尖이침·耳背이배 자락

(2) 사암침 [참고]

· 군화/상화/장열/간열/심열/비열/폐열/신열로 나눠서 치료

✓ 화병

· 스트레스가 기본적으로 많이 쌓여있는 상태 ⇒ 조금만 스트레스 받아도 짜증/화 남

· 구별: ①트라우마, 외상 후 스트레스로 인한 것

큰 사고뿐 아니라, 소소한 일상적인 일에서도 올 수 있음

→ 화병은 열을 꺼주는 게 우선이지만, 이 경우 치료법이 달라짐

②누르고 눌러서 쌓인 것 = 울화

계속 쌓이는 것 → 그때그때 발산해줘야 함 + 심신을 같이 치료

ex. 화병이 심하면 위로 올라가 뒷목, 어깨 부위가 굽고 긴장됨

주로 90% 이상이 여자. 남자의 경우 담아두는 성격인 경우 걸리기 쉬움

4절. 고혈압

1. 개요

: 고혈압이란?

- 인체순환동맥의 혈압이 높아짐에 따라 발생
- 합병증이 없는 한 대부분 증상이 없음
 - ⇒ 우연한 혈압 측정으로 발견할 때가 많음(침묵의 살인자)
- 증상: 두통, 현기증, 전신피로감, 불면, 시력장애, 육혈(衄血), 실신 등
- 한의학의 眩暈현훈, 肝陽上亢간양상항, 頭痛두통, 項強항강 등에 해당

2. 서양의학적 이해

1) 혈압 = 동맥 내의 압력

· 심장에서 추동하는 혈액량에 비례, 동맥의 내경에 반비례

(혈압 = 심박출량 × 혈관저항)

· 수축기 혈압과 이완기 혈압으로 나뉨

→ 정상: 수축기 혈압 120mmHg, 이완기 혈압 80mmHg미만

· 나이가 들수록 증가

✓ 나이 들수록 심장 기능이 약해지므로, 원래 힘만으로는 전신으로 혈액을 보내기

어려움(특히 머리 쪽은 중력에 반해 피를 보내야 해서 더 힘들)

⇒ 따라서 압을 높여서 보내주므로, 나이 들수록 기본 혈압이 높아지는 것은 당연

→ 나이가 있다면 정상 혈압을 120/80보다 여유 있게 생각하기

: 혈압약 먹으면 오히려 저혈압 증상(어지러움, 힘 없음)이 나타난다면 용량을 줄이거나 끊기

· 유전적 성향 강함

2) 고혈압 = 인체순환동맥의 혈압이 높아지는 것

· 비교적 증상 없으나, 뇌중풍·심부전·관상동맥질환 등 치명적 합병증 유발

· 분류 (수축기/이완기)

- 고혈압 전단계: 120-139mmHg / 80-89mmHg → 관리하면 잡히는 경우가 많음

1기 고혈압: 140-159mmHg / 90-99mmHg

2기 고혈압: 160mmHg 이상 / 100mmHg이상

✓ 심한 경우, 한약 치료 하더라도 혈압약을 병행, 합병증의 위험이 있기 때문

· 병태생리

- ① 생활습관: 염분섭취, 비만, 정신적 스트레스, 음주 등
 - ✓ 염분(나트륨) 섭취에 관해서는 의견 분분... 짜게 먹는다고 무조건 혈압 올라가는 것 X. 어떤 고혈압은 소금 섭취와 상관없이, 어떤 것은 민감하게 나타남
 - ⇒ 적당량의 소금은 염증 예방, 극단적인 저염식단은 좋지 않음
 - 소금에 섞여있는 '간수'가 나쁜 것
- ② 레닌-안지오텐신-알도스테론 시스템 (RAAS)
 - 간의 Angiotensinogen을 신장의 Renin이 Angiotensin I으로 변환
 - Angiotensin I을 폐 등에서 활성 높은 교환효소(ACE)가 Angiotensin II로 변환

Angiotensin II의 작용: 혈압상승

- ⇒ 혈관 민무늬근에 작용하여 혈관 수축 → 혈압 상승
- ⇒ 부신피질에 작용하여 알도스테론분비 → 신장에서 나트륨 재흡수 증가 → 혈액량 증가 → 심박출량 증가 → 혈압 상승
- ⇒ 부신피질의 카테콜라민 방출, 교감신경 종말의 노르에피네프린 방출 → β_1 수용체 매개로 심박출량 증가 → 혈압 상승
- ⇒ 뇌하수체 후엽의 ADH(항이노호르몬) 분비 → 신장에서 물의 재흡수 증가 → 혈액량 증가 → 혈압 상승
- ③ 자율신경계: 교감신경 흥분(심수축력·심박동수·심박출량·레닌 증가 등)
- ④ 아디포사이토키인: 비만세포에서 분비. 고혈압·당뇨의 원인

· 위험인자

: 흡연(혈관 수축시킴), 지질대사의 이상, 비만, 고령, 청년기 발병의 심혈관질환의 가족력 등

· 합병증

- 만성적 지속 시 동맥에 장애가 일어나 다양한 장기장애 일어남

- ① 심장: 좌심실 비대, 심부전, 협심증 심근경색 등의 허혈성 심장질환
- ② 뇌신경계: 뇌경색, 뇌출혈, TIA* 등의 뇌혈관장애

*TIA(Transient Ischemic Attack, 일과성 허혈 발작): 뇌쪽 미세한 혈관들이 막히는 것 → 나중에 더 큰 중풍 생길 가능성 ↑

- ③ 신장: 단백뇨, 신장애, 신부전 / 망막: 고혈압성 망막증

- 동맥경화: 내피세포의 장애, 탄성섬유의 피로, 민무늬근세포비대의 자극 등으로 촉진됨

- ④ 혈압이 높으면 혈관에 가해지는 압력 높음 → 부담이 생김 → 혈관의 탄력성이 점점 떨어지고, 딱딱해짐

- ⑤ 피가 세차게 흘러 혈관 안에 상처 생기기 쉬움 → 염증반응

- ⑥ 혈관 안이 좁아져 죽상동맥경화 등 나타남

· 동반 소견

- 정상, 경도: 별 문제 없음
- 중등도: 좌심실의 비대, 단백뇨, AST 상승, 안저동맥의 협착
- 고도: 고혈압성 뇌증, 심장과 신장기능의 쇠약, 안저동맥의 출혈

· 본태성/속발성 고혈압

- ① 본태성(일차성) 고혈압: 원인불명 (90% 이상)

→ 위험인자: 조급한 성격, 비만, 많은 염분 섭취, 정신적 스트레스, 흡연, 음주 등

- ② 속발성(이차성) 고혈압: 원인 有

→ 신혈관병변*, 신실질병변*, 내분비 질환(갈색 세포종*, 원발성 고알도스테론혈증* 등), 중추신경계질환*, 약제(경구 피임약 등), 대사질환*, 임신*, 폐질환 등

* 신혈관병변 = 신장으로 들어가는 동맥에 문제 → 신장으로 들어가는 혈액량 ↓
→ 신장에서 '전체 혈액량이 적은 것'으로 착각 → 레닌 분비 촉진
→ 고혈압

* 신실질병변 = 걸러주는 걸 못함 = 나트륨/수분 배설 못함 → 혈액량 ↑
→ 심박출량 ↑ → 고혈압

* 갈색 세포종, 원발성 고알도스테론혈증: 부신 병변

알도스테론 과잉 분비 → 수분 저류 → 고혈압

* 중추신경계질환: 뇌종양, 뇌출혈 등 → 두개내압 ↑ → 고혈압

초기에 혈압이 확 올라갔다가, 조금 지나면 많이 올라가진 않음

* 질환: 갑상선기능항진/저하증, 쿠싱증후군 등

* 임신 중: 태아에게 혈액을 많이 보내줘야하기 때문

- 고혈압의 치료 및 관리
- 생활습관의 개선: 염분섭취 제한(너무 많이 제한X), 영양관리, 적절한 체중유지, 운동, 금연, 알코올 제한 등
- 강압제: ACE 억제제, 안지오텐신II수용체 길항제, α 차단제(혈관 확장) β 차단제(심박출량·RAA계 억제 → 허혈성 심장질환에 다용) Ca 길항제(혈관 확장 → 뇌혈관문제, 관상동맥 연축성 협심증) 이뇨제(혈액량 감소) 등

3. 한의학적 고찰: 치료

1) 기본치료혈

- 曲池곡지·습곡합곡·內關내관·足三里족삼리·攢竹찬죽·三陰交삼음교

2) 변증치료

(1) 음허양항(陰虛陽亢)(간양상항(肝陽上亢))

- 증상: 頭痛두통 眩暈현훈 耳鳴이명 心悸심계 口乾구건 腰膝酸軟요슬산연 五心煩熱오심번열 (→음허 증상들) 舌嫩紅少苔설눈홍소태 脈細數맥세삭
- 치법: 平肝潛陽평간잠양
- 족궤음·족소양·족소음경 위주로 공보겸시(攻補兼施, 보법+사법 같이)
- **치료혈:** 風池풍지·太衝태충·俠谿협계·太谿태계·三陰交삼음교
✓고혈압에 풍지, 풍부 다용

(2) 신정부족(腎精不足) - 허증

- 증상: 眩暈耳鳴현훈이명 意志無力의지무력 失眠健忘실면건망 腰膝酸軟요슬산연
- 치법: 補腎益精보신익정 / 족소음경, 독맥의 혈&배수혈 위주로 보법 양허자는 구법을 함께 사용
- **치료혈:** 百會백회·風府풍부·腎俞신수·懸鍾현중·太谿태계

(3) 간화상염(肝火上炎)

- 증상: 眩暈현훈 頭脹痛두창통 面赤煩急면적번급 口苦구고 便秘尿赤변비뇨적 舌紅苔黃설홍태황 脈弦맥현
- 치법: 清肝瀉火청간사화 / 독맥·수족궤음경·족소양경 위주로 사법
- **치료혈:** 肝俞간수·風府풍부·行間행간(간의 형화혈)·大陵대릉(심포경)·風池풍지(담경)·陽陵泉양릉천(담경)

3) 기타치료

(1) 사암침법

- 풍현(風眩): 간실(肝實)이므로 간승격(肝勝格)을 씀
- 두정통(頭頂痛): 간약(肝弱)이므로 간정격(肝正格)을 씀

(2) 삼릉침: 십선혈(十宣穴)·두유(頭維)·찬죽(攢竹)에 자락하여 방혈(防血)

4. Tip

- 침구치료를 임상적으로 많이 사용, 효과도 좋음
- 말기 혈압환자는 장기손상 등으로 위급한 상황 유발할 수 있으므로, 침구를 보조적인 요법으로 사용하면서 적절한 약물투입 동반

✓ 저혈압

- 심장 기능이 약하면 추동하는 힘 ↓
 - ① 심장이 더 움직이게 힘을 줌 → 심장 굳음 → 심비대, 심부전증
 - ② 팔다리 쪽으로 보내는 힘 ↓ → 수족냉증
 - ③ 머리 쪽으로 보내는 힘 ↓ → 뇌쪽 퇴행성 질환 ex)건망증, 치매, 심하지 않은 경색

저혈압인 분들도 나이가 들면 고혈압으로 바뀌는 경우가 많음. 죽을 때까지 저혈압인 경우는 많진 않은 듯!